

Cambiamento dei concetti, modelli interpretativi e classificazioni della disabilità

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 05 · 24 marzo 2026

Questa lezione è densa ma fondamentale: capire come sono cambiati i concetti di disabilità nel tempo — e le parole che usiamo per descriverla — è la base per lavorare bene nel settore. Si passa da un'idea di "persona da riparare" a una di "società da adattare". Una rivoluzione copernicana.

Il linguaggio conta: come chiamiamo le persone con disabilità

Prima ancora di parlare di modelli teorici, si apre con un tema pratico: le parole. Le **Raccomandazioni SUPSI "Esprimersi... Diversamente!"** chiariscono che il linguaggio non è neutro — riflette e rinforza la visione che abbiamo della persona.

L'evoluzione terminologica non è capriccio politically correct: segue l'evoluzione dei modelli interpretativi.

Termine (da evitare)	Problema	Termine preferibile
Invalido	Retaggio assicurativo, nega la persona	Persona con disabilità
Handicappato / Disabile (come sostantivo)	Riduce la persona al deficit	Persona con disabilità
Diversamente abile		

Termine (da evitare)	Problema	Termine preferibile
	Presuppone sempre capacità alternative — non è necessariamente vero	Persona con disabilità
Portatore di handicap	La persona <i>vive</i> situazioni di handicap, non le <i>porta</i>	Persona in situazione di handicap
Il cieco / Il sordo	Riduce la persona a un singolo tratto	Persona con disabilità visiva / uditiva

La regola d'oro: **la persona viene prima del deficit**. Non "il disabile" ma "la persona con disabilità". Non "lo studente handicappato" ma "lo studente con disabilità".

La disabilità nel mondo: una realtà che riguarda tutti

La disabilità non è una questione di nicchia. Alcuni numeri che aiutano a capire la scala del fenomeno:

- **Oltre 1 miliardo di persone** nel mondo vive con qualche forma di disabilità (~15% della popolazione mondiale). Se includiamo i familiari direttamente coinvolti, siamo a oltre **un terzo dell'umanità**.
- Gardou (2016) chiama questo fenomeno la "**Terza nazione del mondo**": tutte le persone con disabilità messe insieme formerebbero la terza nazione per popolazione, dopo Cina e India.
- Nei paesi con alta speranza di vita, ogni persona trascorre in media **8 anni della propria vita** in condizione di disabilità.

- In Svizzera: circa **1,8 milioni di persone** con disabilità, di cui **70.000 in Ticino** (Risoluzione della sessione cantonale delle persone con disabilità, 2024).

Il numero non cala — cresce. Perché? Invecchiamento della popolazione, miglioramento delle cure neonatali (più persone sopravvivono con situazioni complesse), conflitti armati, malattie croniche.

Pensaci così: la disabilità non è qualcosa che "appartiene" a una categoria separata di persone. È parte dell'esperienza umana. Prima o poi, tutti ci entreranno in contatto — come persone, familiari, operatori sociali, o nella propria vita personale.

La disabilità è artificialmente raggruppabile in categorie:

- Persone anziane che perdono autonomia
- Persone con deficit sensoriale o motorio
- Persone con deficit cognitivo
- Persone che hanno subito traumi (guerra, incidenti, malattie)
- Persone con problemi di salute mentale
- Persone con disturbi cronici

E per tipo: fisico, mentale, psichico, sensoriale, da dipendenza — congenito (dalla nascita) o acquisito.

L'evoluzione del termine "disabilità"

Il termine ombrello ha cambiato forma nel tempo, e ogni cambio riflette un cambiamento di mentalità:

Periodo	Termine usato	Concetto sottostante
Fine anni '70	Invalido	Riabilitazione, reinserimento lavorativo
Fine anni '80	Handicappato	Integrazione

Periodo	Termine usato	Concetto sottostante
Fine anni '90	Persona disabile	Partecipazione
Dal 2000	Persona con disabilità / Persona in situazione di handicap	Inclusione come diritto

Ogni termine non è solo una parola: è un modo di vedere la persona e il suo rapporto con la società.

I modelli interpretativi della disabilità

La lezione usa un esercizio pratico per illustrare i diversi modi di leggere la stessa situazione:

Caso: Una persona su sedia a rotelle si trova ai piedi di una scala e non può accedere al seggio elettorale. Perché?

Le risposte possibili rivelano il modello mentale di chi risponde:

Modello individuale (centrato sulla persona)

- **Modello biomedico:** perché ha un danno alla spina dorsale
- **Modello funzionale/riabilitativo:** perché non può camminare

In entrambi i casi, il *problema* è nella persona. La soluzione? "Riparare" o compensare la persona.

Modello sociale (centrato sul contesto)

- **Modello ambientale:** a causa della scala, una barriera architettonica
- **Modello civico dei diritti umani:** per un'esclusione sociale, una situazione di discriminazione

Qui il *problema* è nell'ambiente e nella società. La soluzione? Cambiare l'ambiente, garantire i diritti.

Questa distinzione è fondamentale. La **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)** riprende esplicitamente la visione sociale:

"La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri."

Pensa all'albero: la menomazione è un ramo storto, ma è l'ambiente (il vento, il muro, gli altri rami) a determinare se quel ramo diventa un ostacolo o no. La pianta non è "difettosa" — è l'ecosistema attorno che crea o rimuove il problema.

Le classificazioni OMS: il percorso da ICD a ICF

L'OMS ha prodotto nel tempo diversi strumenti di classificazione. Seguire questa evoluzione è come leggere la storia del cambiamento concettuale sulla disabilità.

ICD — International Classification of Diseases (versione attuale: ICD-11)

La logica è lineare e medica:

EZIOLOGIA → PATOLOGIA → MANIFESTAZIONE CLINICA

Si guarda alla *causa* della malattia. Non considera le conseguenze nella vita della persona. Utile per diagnosi clinica, limitato per capire l'impatto sociale.

Questo strumento nasce in un'epoca — dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni '70 — dove il modello dominante era quello della **riabilitazione**: la persona con disabilità è qualcuno da "recuperare" e reintegrare nel lavoro tramite protesi che colmino una mancanza. C'è una *norma* da riacquistare.

Dagli anni '70 questo modello inizia a scricchiolare: il progresso medico porta malattie croniche che non permettono pieno recupero, e l'invecchiamento della popolazione aumenta la fragilità diffusa.

ICIDH — Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (1980)

Un passo avanti importante. L'ICIDH non si ferma alla causa della malattia, ma guarda alle sue *conseguenze*. Introduce tre concetti chiave:

MALATTIA → MENOMAZIONE → DISABILITÀ → HANDICAP

- **Menomazione (impairment):** anomalie, difetti o perdite di organi, arti, strutture o funzioni mentali. È l'esteriorizzazione di uno stato patologico.
- **Disabilità (disability):** qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano.
- **Handicap:** la difficoltà che la persona incontra *nell'ambiente circostante* a causa della menomazione. È uno svantaggio *vissuto*, un problema sociale, non solo individuale.

L'ICIDH è importante perché inizia a introdurre il *contesto* nella lettura della disabilità.

Le critiche all'ICIDH (che porteranno alla sua revisione):

1. La sequenza lineare non è sempre vera: una persona può essere menomata senza essere disabile (es. una persona sorda non è "disabile" in ogni contesto — mentre ascolta musica, non c'è disabilità che emerge)
2. I concetti sono **negativi** — descrivono la persona per ciò che *non sa fare*, creando ulteriori ostacoli all'integrazione
3. Le categorie non descrivono bene anziani, bambini, persone con disturbi psichiatrici
4. Non considera adeguatamente i **fattori ambientali**, che invece hanno un ruolo determinante
5. L'handicap non è visto come concetto dinamico — può essere anche solo temporaneo

Soresi (2016) sottolinea un punto provocatorio: una persona non può essere "globalmente disabile", perché la disabilità emerge solo in certi contesti, quando si pretendono certi livelli di prestazione. Una menomazione agli arti inferiori non è

disabilitante durante una partita di scacchi seduti. Una disabilità visiva non si manifesta mentre si ascolta Mozart. *Al variare del dove, del quando e del con chi*, variano le condizioni sperimentate dalla persona.

Dal PPH all'ICF: verso il modello biopsicosociale

Le critiche all'ICIDH spingono l'OMS a una revisione lunga e articolata. Nel percorso emerge il **Processo di Produzione dell'Handicap (PPH)**, che introduce una visione sistemica:

L'handicap non è una caratteristica della persona — è il risultato dell'*interazione* tra: - **Fattori personali** (sistemi organici, attitudini, capacità) - **Fattori ambientali** (facilitatori o ostacoli) - Le **abitudini di vita** della persona

Se l'ambiente è favorevole, la stessa menomazione produce meno handicap. Se l'ambiente è ostile, anche menomazioni minori diventano fortemente limitanti.

Tappe della revisione:

Anno	Documento	Novità
1980	ICIDH	Menomazione, Disabilità, Handicap
1997	ICIDH-2 bozza beta 1	Spariscono "disabilità" e "handicap" → arrivano "attività" e "partecipazione"
1999	ICIDH-2 bozza beta 2	Classificazione del funzionamento e delle disabilità
2001	ICF	Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
2004	ICF-CY	Versione per bambini e adolescenti

L'**ICF** (2001) è la classificazione attuale. Non classifica più le malattie, ma il **funzionamento** della persona nel suo contesto. Si guarda a cosa la persona *può fare*, non solo a cosa non riesce a fare. I disturbi mentali e cognitivi vengono finalmente posti sullo stesso piano delle disabilità fisiche.

Esclusione, Segregazione, Integrazione, Inclusione

Il cuore pratico della lezione: come le istituzioni hanno storicamente considerato le persone con disabilità. Il modello di Mainardi (2010) distingue quattro forme, leggibili su due assi:

- **Asse X (orizzontale):** luoghi — da *speciali/separati* a *ordinari*
- **Asse Y (verticale):** tipo di attenzione — da *nessuna attenzione* ad *attenzioni speciali*

Esclusione / Ghettizzazione

- Luoghi speciali/separati + **nessuna attenzione** educativa
- L'educazione è un privilegio, non un diritto. Un muro separa chi può beneficiarne e chi no.
- Esempi storici: manicomi, internamenti senza finalità educativa, esclusione dalla società.

Segregazione

- Luoghi speciali/separati + **attenzioni speciali**
- Si creano gruppi omogenei per caratteristiche simili, con l'obiettivo di una prestazione più specialistica.
- Non è automaticamente "male": certi centri specializzati offrono qualità di vita molto alta per persone con necessità elevate (piscine, terapie, accessibilità totale). Per queste persone, la separazione non è esclusione — è risposta adeguata a bisogni specifici.
- Anche la scuola ordinaria funziona in parte in logica segregativa: gruppi per età, per competenze, per territorio.

Integrazione

- Luoghi **ordinari** + **attenzioni speciali**
- La persona con disabilità entra nei contesti comuni, ma con misure speciali e negoziate.

- L'integrazione è **nell'ordine delle possibilità**: richiede battaglie individuali, dipende dalla disponibilità di chi gestisce il contesto.
- **Esempio concreto**: i genitori di un bambino su sedia a rotelle negoziano con la direzione scolastica la costruzione di una rampa *per quel bambino*. Misura speciale, eccezionale, ma possibile.
- Gardou (2016): nell'integrazione è la *persona* che deve adattarsi al sistema preesistente — "un elemento esterno inserito dentro che deve normalizzarsi".

Inclusione

- Luoghi **ordinari** + **attenzioni normalmente speciali**
- Le attenzioni speciali diventano la norma per tutti, a priori.
- L'educazione è rivolta a tutti senza eccezioni, senza costituire gruppi su nessun criterio.
- **Esempio concreto**: tutti gli edifici pubblici hanno rampe *a priori*, indipendentemente dalla presenza di persone su sedia a rotelle. La misura è pensata per tutta la popolazione — utile anche a mamme con passeggino, ciclisti in stazione, anziani con bagagli.
- Gardou (2016): una società inclusiva "sa modulare il proprio funzionamento, diventa flessibile per offrire a tutti un luogo in cui sentirsi a casa."

Attenzione importante: **questo schema non è una scala del bene e del male**. La prof. sottolinea con forza che non c'è un giudizio di valore automatico. In certi momenti, per certe persone, la soluzione migliore per la qualità di vita è separativa. La stessa struttura, la stessa persona, possono spostarsi su questo schema a seconda del momento e del bisogno.

L'inclusione: ideale, utopia e i suoi rischi

L'inclusione è oggi la parola di moda — e questo crea problemi.

Il problema della banalizzazione

La prof. porta l'esempio di Sanremo: un coro di persone con disabilità cognitive, vestite con magliette rosse con scritto "solo come te", presentato come "momento inclusivo". Per la prof. era il contrario: persone segregate su un palco, trattate in modo paternalistico, non valorizzate individualmente. Le associazioni per i diritti delle persone con disabilità avevano già scritto a Sanremo chiedendo di non parlare di disabilità in quel modo.

L'inclusione è diventata un'etichetta da applicare a qualsiasi cosa, anche a pratiche che non hanno niente di inclusivo.

L'inclusione come direzione, non come stato raggiunto

La risposta della prof. alla domanda "L'inclusione è un'utopia?": sì, è un'utopia — ma è la direzione. Per alcune categorie si è già progredito molto: gli immigrati italiani negli anni '60-'70 in Svizzera erano esclusi, oggi quel livello di esclusione non esiste più. Con le disabilità fisiche, grazie a tecnologia e norme di accessibilità, molte persone sono molto più incluse di 30 anni fa.

Il rischio del "mettere dentro senza garantire"

Se creo contesti inclusivi ma poi taglio le risorse per i sostegni, piano piano le persone vengono dimenticate e ri-escluse. Non basta "mettere dentro" — bisogna continuare a garantire le attenzioni speciali nel tempo. Il rischio dell'inclusione senza risorse è tornare all'esclusione di partenza.

Oltre l'inclusione?

Una sociolinguista citata a lezione fa notare che la stessa parola "inclusione" porta un problema: implica che qualcuno *include* qualcun altro. C'è ancora una relazione asimmetrica. L'ideale successivo sarebbe la **vera convivenza nella differenza** — ma le parole per descriverla ancora non abbiamo.

Gardou propone di usare soprattutto l'**aggettivo inclusivo** (scuola inclusiva, educazione inclusiva) perché porta il valore dell'inclusione sul piano delle pratiche concrete — qualcosa su cui possiamo agire ogni giorno.

La lingua facile: integrativa o inclusiva?

La **lingua facile** è una modalità di scrittura semplificata (parole comuni, frasi brevi, layout chiaro) per rendere i testi accessibili a persone con difficoltà cognitive o di lettura.

La domanda posta a lezione: è uno strumento integrativo o inclusivo?

- Se disponibile *solo per chi la richiede* (es. un telegiornale speciale in certi orari) → **integrativa**: misura speciale eccezionale per persone specifiche
- Se *tutti i testi* (circolari scolastiche, documenti medici, comunicazioni dei comuni) fossero in lingua facile *a priori* → **inclusiva**: misura normale per tutta la popolazione

Lo **strumento in sé** è inclusivo: rendere la comunicazione più chiara beneficia chiunque. Il suo *utilizzo* contestuale può essere integrativo, inclusivo, o addirittura segregativo a seconda di come viene applicato.

Concetti chiave

Termine	Significato
Menomazione (impairment)	Danno organico o funzionale (organi, strutture, funzioni mentali)
Disabilità (disability)	Perdita di capacità operative conseguente alla menomazione
Handicap	Svantaggio vissuto dalla persona nell'interazione con l'ambiente
ICD	Classifica le malattie per cause — modello medico/riabilitativo
ICIDH	Classifica le conseguenze delle malattie — introduce menomazione, disabilità, handicap (1980)

Termine	Significato
ICF	Classifica il funzionamento della persona nel contesto — modello biopsicosociale (2001)
PPH	Processo di Produzione dell'Handicap — modello sistemico persona-ambiente
Esclusione	Luoghi speciali + nessuna attenzione educativa
Segregazione	Luoghi speciali + attenzioni speciali
Integrazione	Luoghi ordinari + attenzioni speciali (misure eccezionali, negoziate)
Inclusione	Luoghi ordinari + attenzioni normalmente speciali (per tutti, a priori)
Lingua facile	Scrittura semplificata per rendere i testi accessibili a tutti
Persona con disabilità	Terminologia corretta: la persona viene prima della disabilità

Collegamenti

- **Lezioni 01-04:** movimenti associativi e Convenzione ONU (CDPD, 2006) — base valoriale da cui derivano i cambiamenti concettuali discussi qui
- **Libro di Gardou** (*Nessuna vita è minuscola*, 2016): approfondisce inclusione, diritti e visione di una società senza esclusi
- **Mainardi (2010):** schema dei quattro modelli istituzionali (esclusione, segregazione, integrazione, inclusione)
- **Soresi (2016):** analisi critica delle classificazioni OMS e della loro evoluzione
- **Da approfondire:** Universal Design for Learning (UDL) — progettare ambienti di apprendimento accessibili a tutti fin dall'inizio